



Collection MedWIZ

5^e année médecine

PÉDIATRIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Cours :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Suivi de l'enfant normal	10				
02	Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l'enfant	12				
03	Développement psychomoteur de l'enfant	14				
04	Rachitisme carenciel commun	16				
05	Puberté normale et variations	18				
06	Vaccination chez l'enfant	20				
07	Obésité de l'enfant	24				
08	Dyspnée aiguë et chronique	26				
09	Infections respiratoires aiguës chez l'enfant	28				
10	Asthme de l'enfant et du nourrisson	32				
11	Tuberculose chez l'enfant	36				
12	Détresse respiratoire aiguë chez l'enfant et le nourrisson	38				
13	Masses thoraciques de l'enfant	40				
14	Méningite et méningo-encéphalite chez l'enfant	42				
15	Convulsions et épilepsie de l'enfant	46				
16	Diabètes de l'enfant (DT1 et DT2)	52				
17	Complications aiguës du diabète	54				
18	Dysthyroïdies de l'enfant	58				
19	Syndrome post-streptococcique	62				
20	Protéinurie et syndrome néphrotique	66				
21	Infections urinaires chez l'enfant et uropathies malformatives	70				
22	Dysurie et énurésie	74				
23	Arthrite juvénile idiopathique (AJI)	76				
24	Éruptions fébriles de l'enfant	78				

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
25	Anémie de l'enfant	82				
26	Syndrome hémorragique de l'enfant	84				
27	Tumeurs abdominales chez l'enfant	86				
28	Vomissements de l'enfant	88				
29	Diarrhée aiguë et déshydratation chez l'enfant	92				
30	Diarrhées chroniques de l'enfant	96				
31	Constipation et encoprésie de l'enfant	98				
32	Douleur abdominale aiguë et chronique de l'enfant	100				
33	Urgences abdominales chirurgicales pédiatriques	102				
34	Pathologies génito-scrotales chez le garçon	106				
35	Arrêt cardio-respiratoire (ACR)	108				
36	États de choc chez l'enfant	110				
37	Coma non traumatique chez l'enfant	114				
38	Malaise grave du nourrisson et mort subite	116				
39	Adaptation à la vie extra-utérine	118				
40	Prématurité et retard de croissance intra-utérin (RCIU)	120				
41	Détresse respiratoire néonatale	124				
42	Ictères néonataux	128				
43	Traitement et prévention des infections néonatales (IN)	132				
44	Cyanose du nouveau-né	134				

II. Travaux dirigés :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
45	Examen du nouveau-né	140				
46	Allaitement maternel	142				
47	Retard de croissance staturo-pondéral	144				
48	Fièvre aiguë chez l'enfant	146				
49	Souffle cardiaque chez l'enfant	148				
50	Hématurie	150				
51	Transfusion sanguine en pédiatrie	152				
52	Dermatoses courantes en pédiatrie	156				
53	Interprétation de l'imagerie chez l'enfant	160				
54	Maltraitance et enfants en danger	162				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Cours

© 2026 The WIZ. Tous droits réservés.

SUIVI DE L'ENFANT NORMAL

I. OBJECTIFS PRINCIPAUX

- Assurer le suivi du nourrisson, enfant et adolescent normal
- Dépister les troubles sensoriels (vision/audition) et anomalies orthopédiques
- Prévention et dépistage précoce

II. ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT

- Période intra-utérine (embryonnaire + fœtale)
- Néonatale (J0-J28) : adaptation à la vie extra-utérine
- 1^{ère} enfance (29j-2ans) : croissance somatique et psychomotrice intense
- 2^{ème} enfance (2-12 ans) : croissance lente, maturation
 - Préscolaire (2-6 ans)
 - Scolaire (6-12 ans)
- Adolescence (G: 13-16 ans / F: 11-13 ans) : croissance pubertaire

III. MORTALITÉ INFANTILE

(Algérie - OMS 2022)

- Néonatale : 15,2 %
- Infantile (<1 an) : 18,7 %
- Infanto-juvénile (<5 ans) : 21,8 %

IV. EXAMENS SYSTÉMATIQUES PAR ÂGE

ÂGE	OBJECTIFS CLÉS
Néonatal	Adaptation extra-utérine, dépistage malformations (cardiaques, orthopédiques), troubles sensoriels
Nourrisson	Croissance staturo-pondérale, développement psychomoteur, conseils diététiques (vit K/D), vaccination
2 ^{ème} enfance	Croissance, langage, acquisitions sphinctériennes, comportement, troubles sensoriels
Scolaire (6 ans)	Croissance, latéralité/écriture, THDA, vision/audition, vaccination 6 ans
Adolescence	Croissance (obésité, retard), troubles alimentaires, stade pubertaire (Tanner), scoliose, toxiques

V. DÉPISTAGE AUDITIF

- Naissance : OEA et PEAP pour surdités profondes
- Facteurs de risque : ATCD familiaux, prématurité (<1500g), infections congénitales, méningite, otites répétées
- Signes d'appel : absence de réaction au son, retard de parole, troubles comportement/scolaires

VI. DÉPISTAGE VISUEL

- Signes d'appel : strabisme (pathologique après 4 mois), nystagmus, torticollis, anomalies comportementales
- Examens :

ÂGE	EXAMENS
< 2 ans	reflets cornéens, fixation, poursuite
2-4 ans	optotypes images, test de Lang
6 ans	optotypes lettres, vision des couleurs

VII. ANOMALIES ORTHOPÉDIQUES

- Pieds : metatarsus adductus/varus, pied bot varus équin (urgence néonatale)
- Scoliose : déformation 3 plans (diagnostic : gibbosité, angle de Cobb)
- Membres inférieurs : dépistage LCH jusqu'à 6 mois
- Évolution physiologique :
Genu varum (0-2 ans) → Genu valgum max à 3-4 ans → tendance selon sexe après 10 ans

VIII. DÉPISTAGE BIOLOGIQUE NÉONATAL

- Métabolique : phénylcétonurie, MCAD, tyrosinémie
- Endocrinienne : hypothyroïdie congénitale (1^{ère} cause de déficit mental évitable), hyperplasie surrénalienne
- Autres : mucoviscidose, drépanocytose

IX. CARNET DE SANTÉ

- Rôle : lien entre professionnels, suivi de la naissance à l'adulte
- Contenu : données prénatales, anthropométrie, examens, vaccinations, courbes de croissance, conseils prévention
- Nouvelle version algérienne : 2023